

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСШИРЕННО- КОМБИНИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО

Баймухаметов Э. Т.

Казахский НИИ онкологии и радиологии,

г. Алматы, Республика Казахстан

В клиническую практику прочно вошли расширенно-комбинированные операции при местнораспространенном раке легкого. К расширенно-комбинированным оперативным вмешательствам при раке легкого относятся те операции, при которых вместе с пораженной долей легкого или легким удаляются вовлеченные в опухолевый процесс соседние органы и ткани (перикард, пищевод, плевра, ребра и др.) с обязательной лимфодиссекцией. Хирургическое лечение больных с местнораспространенным опухолевым процессом отличаются технической сложностью и высокой травматичностью, сопровождаются значительным количеством послеоперационных осложнений и высокой послеоперационной летальностью (Давыдов М. И., 2003; Бебия Н. В., Бисенков Л. Н., Гришаков С. В., 2004; Барчук А. С., 2006).

За период с 1995 по 2010 годы в клинике Казахского НИИ онкологии и радиологии (зав. отделом – д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РК Бейсебаев А. А.) выполнено 155 расширенно-комбинированных операций. Все больные имели IIIa-IIIb стадию опухолевого процесса. Соотношение мужчин и женщин представлено как 9:1. Возраст больных колебался от 28 до 76 лет. У 55,7% больных патологический процесс располагался справа, у 44,3% слева. Анализируя данные, касающиеся объема оперативных вмешательств, больше всего выполнено пневмонэктомией с частичной и субтотальной перикардэктомией – 46,2%, производились операции и с резекцией бифуркации трахеи. Кроме резекции перикарда выполнены операции с резекцией верхней полой вены, легочной артерии, участка диафрагмы, париетальной плевры, ребер. Во всех случаях произведена широкая медиастинальная лимфодиссекция. Дефект перикарда замещался лавсановой сеткой для профилактики «вывиха сердца». Частота послеоперационных осложнений составила 22,3%, послеоперационная летальность – 8,3%. Среди гистотипов распределение было следующим: плоскоклеточный рак (70,5%), аденокарцинома (22,3%), другие формы (7,2%).

Общая 1-3-5-летняя выживаемость составила 75,6%; 39,2% и 28,1% (при плоскоклеточном раке – 77,9%; 43,4% и 27,1%; при аденокарциноме – 82,7%; 27,4% и 0%, соответственно). 1-3-5-летняя выживаемость в зависимости от вовлеченности в опухолевый процесс лимфатических узлов средостения (N) составила: при N₀ – 76,6%; 46,0% и 33,2%, а при N₂ – 66,8%; 27,4% и 14,6%, соответственно.

Таким образом, при хирургическом лечении больных с местнораспространенным раком легкого нами использовались технические приемы расширенно-комбинированных операций путем выполнения лоб- и билобэктомий, пневмонэктомий с резекцией участков соседних органов и лимфодиссекции, а так же сочетание расширенно-комбинированных операций с резекцией и пластикой бронхов и бифуркации трахеи.

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ – СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Касымов Г.П., Голентовский М.В., Мусин Ж.Е.

Высшая Школа общественного здравоохранения

Актуальность. Среди распространенности злокачественных новообразований женского населения г. Алматы рак шейки матки занимает третье место при ранговом

распределении нозологических форм злокачественных новообразований и среди всего населения – шестое место в структуре смертности населения. В связи с этим, вакцинопрофилактика рака шейки матки является приоритетным направлением при проведении профилактических программ развития онкологических заболеваний. Основным этиологическим агентом рака шейки матки является вирус папилломы человека (ВПЧ). Папилломавирусная инфекция относится к инфекциям, передаваемым половым путем. По данным ВОЗ за последнее десятилетие количество инфицированных больных ВПЧ увеличилось в десять раз.

Особенностью папилломавирусной инфекции является отсутствие в настоящее время методов специфической терапии. Поэтому первичная профилактика заболеваний, ассоциированных с папилломавирусной инфекцией, заключается в предотвращении заражения и достигается путем реализации комплекса профилактических мероприятий. В связи с этим, уровень информированности женского населения о распространенности рака шейки матки является актуальным.

Цель работы. изучение уровня информированности детского, подросткового и взрослого населения о факторах риска и знании проблемы рака шейки матки.

Материалы и методы. Проведено анкетирование 820 девочек, девушек-подростков и женщин в возрасте от 10 до 35 лет. Анкета включала 40 вопросов, касающихся информированности о развитии рака шейки матки, ассоциации данного заболевания с ВПЧ, путях передачи данного вируса и проведенных вакцинопрофилактики против рака шейки матки. Сбор материала проводился в школах и женских консультациях г. Алматы.

Результаты и выводы. Исследование уровня знаний распространенности рака шейки матки свидетельствует, что в возрасте 10-15 лет 95% девочек и девушек-подростков не знают о данном заболевании; в возрасте 16-20 лет только 48% девушек-подростков и женщин имели представление о развитии данного заболевания; в возрасте 21-30 лет 56% женщин имели понятия о развитии данной патологии и в возрасте 31-35 лет 67% были информированы о данном заболевании. Вместе с тем, из общего числа опрошенных девушек и женщин скрининговое исследование на наличие рака шейки матки имели всего 1 девушка в возрасте 17 лет и 5 женщин в возрасте 21-30 лет. При этом, несмотря на рекомендации специалистов, что сплошная вакцинация против развития ВПЧ позволяет сокращать число заболевших женщин раком шейки матки на 60%, из числа опрошенных респонденток ни одна не получала вакцинопрофилактику.

Таким образом, низкая информированность женского населения о причинах развития и мерах профилактики рака шейки матки предопределяет необходимость, как проведения санитарно-просветительной работы с привлечением средств массовой информации, медицинских и образовательных учреждений, так и предусматривает обратить пристальное внимание на необходимость проведения первичной профилактики рака шейки матки в связи с высокими показателями заболеваемости и смертности от данного заболевания в г. Алматы.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ОБТУРАЦИОННОЙ ОСТРОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ КИШЕЧНИКА

Мадьяров В.М.

Кафедра хирургических болезней

Актуальность. Острая непроходимость кишечника (ОНК) наиболее сложна для диагностики, характеризуется тяже-

лым клиническим течением и высокой летальностью среди различных заболеваний ургентной абдоминальной хирургии. При решении вопроса о лечебной тактике необходимо учитывать уровень непроходимости, вид нарушения проходимости (форм кишечной непроходимости), длительность заболевания, выраженность клинической картины, наличие осложнений и сопутствующих заболеваний. Не меньшей проблемой является и уровень резекции кишечника при его некрозе, а также интраоперационная интубация кишечника и послеоперационное ведение.

Все еще высокая летальность в этой группе больных – 13–26%, что требует дальнейших поисков более совершенных методов диагностики и оптимизации

Цель работы. Исследование аспектов оказания медицинской помощи и тактика введения больных с обтурационной кишечной непроходимостью вследствие злокачественного образования.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 2650 больных острой кишечной непроходимостью, в возрасте от 12 до 96 лет, из них 67,8% моложе 60 лет. Мужчины составили 44%, женщины – 56%.

У 275 (10,4%) больных выявлялась обтурационная кишечная непроходимость (при этом, у 88,7% больных этой группы обтурация кишечника вызвана злокачественными опухолями). Следует отметить возрастание доли толсто - кишечной непроходимости на почве злокачественных опухолей (с 1,8% до 10-14 % за период 2005-2010 годов).

Результаты и выводы. Исследование больных обтурационной кишечной непроходимостью, вызванной злокачественными новообразованиями, показывает, что в 72% случаев причиной позднего поступления данного контингента больных явилось несвоевременное обращение за медицинской помощью, причем 26,7% больных занимались самолечением. В 28% случаев больные обращались в различные лечебные учреждения, причем, 9% из них доставлялись в дежурные хирургические стационары и были отпущены домой сразу из приемного покоя или после 1–2 дневного стационарного наблюдения.

При обтурационной кишечной непроходимости, причиной которой явились обтурации злокачественные опухоли, прооперированы 49,4% больных.

Снижению летальности при толсто - кишечной обтурационной непроходимости раковой этиологии способствует отказ от радикальных операций с первичным восстановлением проходимости кишечника в ургентных ситуациях и, в тоже время, повышение экстренной хирургической активности, направленной на разгрузку кишечника, благодаря более широкому применению экстренной контрастной ирригоскопии, улучшившей раннюю диагностику этой причины обтурации.

Следует отказаться и от первичных анастомозов после резекции омертвевшего сегмента толстой кишки при непроходимости любой другой этиологии в пользу операции типа Гартмана.

Отмечены особенности клинической картины, обсуждается лечебная тактика, основой которой является своевременное оперативное пособие, интубация кишечника, объем хирургического вмешательства для устранения причины непроходимости при отказе от излишнего радикализма при тяжелой клинической ситуации.

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПЕРЕНЕСШИХ РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Казакова А.В.

Клиника «Жан», г. Алматы

Актуальность. Исследование качества жизни в онкологической практике открывает возможности точного описания

и измерения сложной гаммы многоплановых нарушений, которые происходят с онкологическим больным в процессе развития злокачественной опухоли. При развитии онкологического процесса больной переживает критические изменения во всех сферах жизнедеятельности – физической, психической, духовной и социальной.

С этих позиций, исследование качества жизни у женщин, перенесших оперативные вмешательства по поводу рака молочной железы, и одновременно, или позднее ее реконструктивную пластику, вызывает значительный научный интерес.

Цель работы. Проведение сопоставительного анализа исследования параметров качества жизни у женщин, перенесших оперативные вмешательства по поводу рака молочной железы, с реконструктивными и без реконструктивных операциями.

Материалы и методы. Обследуемые женщины составили I группу (70 человек), у которых была произведена резекция молочной железы по поводу рака со II-III стадии, II группу составили 56 женщин, перенесшие после удаления опухоли молочной железы (II-III стадия опухолевого процесса) реконструктивную пластику. Наблюдение проведено в течение трехлетнего периода. Женщинам обеих групп была проведена химиотерапия и поддерживающая терапия. Работа выполнялась на кафедре онкологии Российского университета дружбы народов.

В исследовании использован опросник MOS SF-36 – наиболее применяющийся в популяционных и специальных исследованиях качества жизни.

Исследование качества жизни у больных раком молочной железы показывает, что по некоторым шкалам опросника MOS SF-36, отличия между показателями качества жизни у двух групп больных была различными. Физическое функционирование больных раком молочной железы I группы по сравнению со II группой было повышено на 52,5% и составляет 33,2 балла; ролевое физическое функционирование повышено на 62,0% и равно 9,4 балла. Показатель боли во II группе имеет снижение на 22,4% и составляет 1,0 балл. Одновременно, параметры общего здоровья у женщин II группы были повышены на 35,6% и равны 16,8 баллам, жизнеспособность на 40,1% и составляет 6,5 балла; эмоциональное функционирование на 55,0% - 1,9 балла; уровень психического здоровья выше на 65,5%, и составляет 3,8 балла.

Результаты и выводы. Таким образом, сравнение показателей качества жизни у больных раком молочной железы со II-III стадией опухолевого процесса с наличием или без наличия реконструктивной пластики молочной железы, демонстрирует значительную разницу в показателях качества жизни (особенно, в физическом функционировании, ролевом физическом функционировании, эмоциональном функционировании и уровне психического здоровья). Представленные методические подходы по оценке качества жизни больных со злокачественными новообразованиями молочной железы, способствуют не только проведению мониторинга за состоянием здоровья, проведению реабилитационных программ, но и служат важнейшими критериями ремиссии и выздоровления онкологических больных.

К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОМПОНЕНТАМИ КРОВИ БОЛЬНЫХ НА УРОВНЕ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Ержанов К.Д.

Республиканский Центр крови, г. Алматы

Актуальность. В последние два десятилетия серьезной проблемой для политики в области здравоохранения в различных государствах являются злокачественные ново-

образования. Вместе с тем, двадцатилетний путь развития онкологической науки, происшедший на стыке двадцатого и двадцать первого веков, символичен не только разработками лекарственных форм, уменьшающих страдания больных и препаратов, определяющие группу риска развития злокачественных новообразований, но и эффективным использованием гемотрансфузионных средств.

С изменениями протоколов ведения больных, меняется потребность в компонентах крови. В условиях современной онкологии снижается потребность в эритроцитах, но возрастает потребность в свежемороженой плазме. При этом, в онкогематологии терапия невозможна без использования больших количеств тромбоцитарной массы.

Исходя из опыта клинической онкологии показано, что достижение оптимального лечебного эффекта при плановых и экстренных оперативных вмешательствах в онкологии, в значительной степени, связано с выбором варианта их трансфузиологического обеспечения. Вариативность ситуаций, обусловленных характером и тяжестью заболевания (наличием опухоли и обширностью ее размеров), объемом оперативного вмешательства и величиной сопутствующей ему потери крови, определяют необходимость индивидуализации программы трансфузиологического обеспечения операции у каждого конкретного пациента.

Цель работы. Определение динамики обеспеченности специализированного онкологического учреждения компонентами крови для лечения онкологических больных.

Материалы и методы. Проведен анализ обеспечения трансфузионными средами Казахского Научно-исследовательского института онкологии и радиологии за период 2005-2009 годов. На основе отчетных данных и учета выдачи трансфузионных сред определены динамические и структурные показатели использования гемокомпонентов в специализированном онкологическом учреждении.

Результаты и выводы. Исследование динамики обеспечения компонентами крови пациентов клиники КазНИИОиР (Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии) показывает, что в 2009 году по сравнению с 2005 годом почти не изменилось количество перелитой плазмы (91,480 л и 95,820 л, соответственно). Однако, на 98,1% увеличилось переливание свежемороженой каратинизированной плазмы (4,720 л – 243,980 л); на 67,5% увеличилось переливание антистафилококковой свежемороженой каратинизированной плазмы; на 80,9% повысилось обеспечение больных со злокачественными новообразованиями эритроцитарной массой (39,450 л – 206,640 л); отмечается положительные сдвиги в использовании переливания 5% альбумина на 84,3% (1,950 л – 12,400 л). Такая же тенденция имеет место и при переливании криопреципитата замороженного. прирост на 85,7% (6 доз – 42 дозы). Вместе с тем, снизилось в 3,1 раза потребление плазмы антистафилококковой свежемороженой (7,630 – 2,480 л).

Внедрение в работу Республиканского Центра крови инновационных технологий заготовки, производства, хранения и транспортировки компонентов крови, безусловно, повлияло на обеспечение специализированной онкологической службы компонентами крови, современными технологическими процессами лейкофилтрации и криоконсервирования эритроцитов, что позволило значительно увеличить объемы перелитых компонентов крови, и в 2009 году соответствует 1141,088 л, включая эритроцитарную взвесь лейкофилтрированную, концентрат тромбоцитов, 5%, 10% и 20% альбумин, стандарт изогемагглютинирующий сыворотки, универсальный реагент анти-резус и другие

компоненты, что намного превышает объемы перелитых компонентов крови в 2005 году (162,546 л) без учета криопреципитата замороженного и эритроцитарной взвеси.

Таким образом, за пятилетний период (2005-2009 годы) в 7 раз увеличились объемы перелитых компонентов крови в КазНИИОиР, что позволяет в достаточной степени, обеспечить специализированную онкологическую службу гемотрансфузионными препаратами, и предопределить эффективное лечение онкологических больных.

МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Никипорец М.В.

Казахский Национальный Медицинский Университет им. С. Д. Асфендиярова, г. Алматы

Актуальность. Для определения объема хирургических вмешательств больным с заболеваниями челюстно-лицевой локализации и структуры хирургической патологии на уровне оказания стационарной помощи, необходимы расчеты показателей госпитализированной заболеваемости различных групп населения.

Цель работы. Проведение углубленного анализа госпитализированной заболеваемости населения г. Алматы по поводу новообразований челюстно-лицевой области на основании определения показателей заболеваемости детского, подросткового и взрослого контингентов.

Материалы и методы. Исследование проведено путем выкопировки сведений из истории болезни больных, находившихся на стационарном лечении в городской клинической больнице № 5 г. Алматы, Аксайской республиканской детской больницы и Алматинской областной больницы. В статистическую обработку включены все случаи госпитализации с новообразованиями челюстно-лицевой области, на основании которых и были рассчитаны показатели госпитализированной заболеваемости за период 2007-2009 годов.

Результаты и выводы. В структуре всех хирургических заболеваний челюстно-лицевой области среди детского населения г. Алматы, включающих врожденные и приобретенные дефекты, деформации и аномалии челюстно-лицевой области; одонтогенные и неодонтогенные воспалительные заболевания; травмы челюстно-лицевой области и доброкачественные опухоли и опухолевидные образования, на долю последних приходится 10,0% - среди детского контингента; среди подростков и взрослого населения, соответственно, данный показатель составляет: 10,8%. В группе доброкачественных опухолей и опухолевидных образований представлены следующие нозологические формы, соответственно, по детскому и взрослому контингенту: амелобластома – 7,7; 0,7; остеобластокластома и другие костные опухоли – 6,9; 2,5; опухоли мягких тканей (включая гемангиомы и лимфангиомы) – 29,8; 28,2; опухоли слюнных желез – 9,7; 4,2; прочие – 5,8; 0,9 на 100 тысяч человек населения (средний показатель за период 2007 – 2009 годов).

Таким образом, проведенное исследование позволило провести идентификацию показателей заболеваемости новообразованиями среди детского и взрослого населения г. Алматы на основании структуры и частоты отдельных нозологических форм, на уровне оказания первичной медико – санитарной помощи и нацеливает на необходимость проведения профилактических мероприятий не только врачей – онкологов, но и челюстно – лицевых хирургов, и специалистов первичного звена здравоохранения.

ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Мейрбеков М.Б.

Управление здравоохранением Алматинской области, г.Талдыкорган

Актуальность. Злокачественные новообразования относятся к группе важнейших неэпидемических заболеваний, значимость которых связана не только с их широким распространением, но и с их вкладом, которые эти заболевания составляют в общей структуре смертности и инвалидизации населения, а также в экономическом ущербе государства из-за временной утраты трудоспособности, инвалидности и преждевременной смерти.

Цель работы. Анализ показателей заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований среди населения Алматинской области в результате внедрения профилактических программ по снижению онкологической патологии.

Материалы и методы. Объектами исследования избраны онкологические учреждения Республики Казахстан. На основании статистического метода проведен учет каждого случая заболевания и смерти вследствие онкологической патологии.

Результаты и выводы. Анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом) в Республике Казахстан в 2008 году составляет 180,7 на 100 тысяч человек населения, в 2001 году данный показатель равен 195,9 на аналогичную численность населения. В Алматинской области в 2001 году заболеваемость злокачественными новообразованиями составляет 149,0 и в 2008 году – 128,0 на 100 тысяч человек населения.

Наряду с этим, показатели смертности имеют аналогичную тенденцию и соответствуют следующим данным: в 2001 году по Республике Казахстан число умерших от злокачественных новообразований равно: 134,4; в 2008 году – 114,9 на 100 тысяч человек населения. В то же время, по Алматинской области анализируемый показатель соответствует - 100,9 (2001 год) и 92,9 (2008 год) на 100 тысяч человек населения. То есть, как по показателям заболеваемости, так и по показателям смертности населения от злокачественных новообразований Алматинская область имеет более низкие показатели по сравнению со средне-республиканскими. Данный факт, в значительной степени, связан с принятием и проведением территориальной программы по снижению онкологической заболеваемости, увеличением объемов социальных программ, активным функционированием системы здравоохранения по своевременному и качественному оказанию специализированной медицинской помощи, а также стратегическому планированию онкологической помощи.

Проведение углубленных медицинских осмотров в рамках территориальной программы по снижению онкологической патологии в Алматинской области способствует формированию групп повышенного онкологического риска на основе критериев отбора и проведения профилактического лабораторно – инструментального обследования с целью выявления ранней онкологической патологии.

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Казакова А.В.

Клиника «Жан», г. Алматы

Актуальность. Важнейшим физическим недостатком и серьезной психической травмой является потеря женщиной

молочной железы после радикального лечения по поводу рака, в связи с чем, женщине очень трудно вести полноценную жизнь в обществе. Женщины не могут смириться с потерей молочной железы. Потеря груди разрушает самовосприятие женщины и поддерживает память о перенесенном заболевании. Пациентки, после удаления груди, в 85% испытывают чувство неполноценности, в 80% — депрессию, отчаяние, в 40% — исчезновение либидо, в 30% — происходит распад семьи. Все эти причины обуславливают актуальность проблемы реконструкции молочной железы, после проведения радикальной мастэктомии.

Цель работы. провести анализ методических подходов по использованию различных видов реконструкции молочной железы с одномоментной онкологической операцией.

Материалы и методы. Работа выполнена на кафедре онкологии Российского университета дружбы народов. Исследовано 120 женщин с раком молочной железы I-III стадий, которым была произведена реконструкция молочной железы одномоментно с онкологической операцией. радикальной мастэктомией и реконструкцией с использованием ПРАЛ (поперечным ректоабдоминальным лоскутом) – 65 пациенток, которым одномоментно с онкологической операцией проводилась непосредственно реконструкция с использованием ПРАЛ и 55 пациенток с использованием кожно-жирового лоскута на широчайшей мышце спины с использованием эндопротеза.

Результаты и выводы. После органосохраняющих операций с первичной реконструкцией молочных желез проведена лучевая терапия на молочную железу и зоны регионарного метастазирования. Все пациентки в предоперационном периоде получали химиотерапию или химиолучевое лечение, и после операции – профилактическую химиотерапию. Кроме того, пациентки получали также эндокринную терапию в соответствии со стадией болезни и рецепторным статусом опухоли. После реконструкции молочной железы ПРАЛ серьезных осложнений не отмечено. У тех женщин, которые перенесли реконструкцию молочной железы с использованием лоскута на широчайшей мышце спины, были отмечены осложнения в 12 % случаях (грыжа, краевой некроз лоскута).

Таким образом, использование инновационных технологий и интенсивное развитие пластической и реконструктивной хирургии, разработка пластических и реконструктивных операций на молочной железе с помощью ПРАЛ не только способствует восстановлению молочной железы, но наряду с решением психологических проблем у женщин, предусматривают хорошие косметологические результаты. При этом, преимуществом этих методов является то, что железа, сформированная из собственных тканей пациентки – более естественная и однородная в отличие от отторжения протеза, нередко наблюдающееся при его использовании. Одновременно с этим, при выполнении первичной реконструкции ПРАЛ не препятствует проведению химиолучевой терапии в послеоперационном периоде, послеоперационное облучение в обычных дозах не повреждает ПРАЛ. В то же время, реконструкция молочной железы с использованием ПРАЛ не только не ухудшает заживление послеоперационной раны, но и улучшает заживление у пациенток, получивших предоперационную лучевую терапию. Не смотря на длительность операции с ПРАЛ и ее травматичности, определяется медицинская эффективность при использовании первичной реконструкции молочной железы при раке. Следовательно, использование собственных тканей для первичной пластики молочной железы не служат препятствием для проведения пред- и послеоперационного лучевого лечения. Выбор варианта реконструктивного вмешательства зависит от объема онкологической операции, оценки соматического состояния пациентки и ее желания.